

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Reumatismo no articular - Lumbalgia

Lic. Cesar Borja Arenas
T.M. en Terapia Física y Rehabilitación

Presente.



Reconocer las principales características clínicas de lumbalgia y los lineamientos para el **Presente.** en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 05: Reumatismo no articular - Lumbalgia

1. Lumbalgia
2. Signos y síntomas
3. Clasificación
4. Factores de riesgo
5. Objetivos
6. Programa de tratamiento

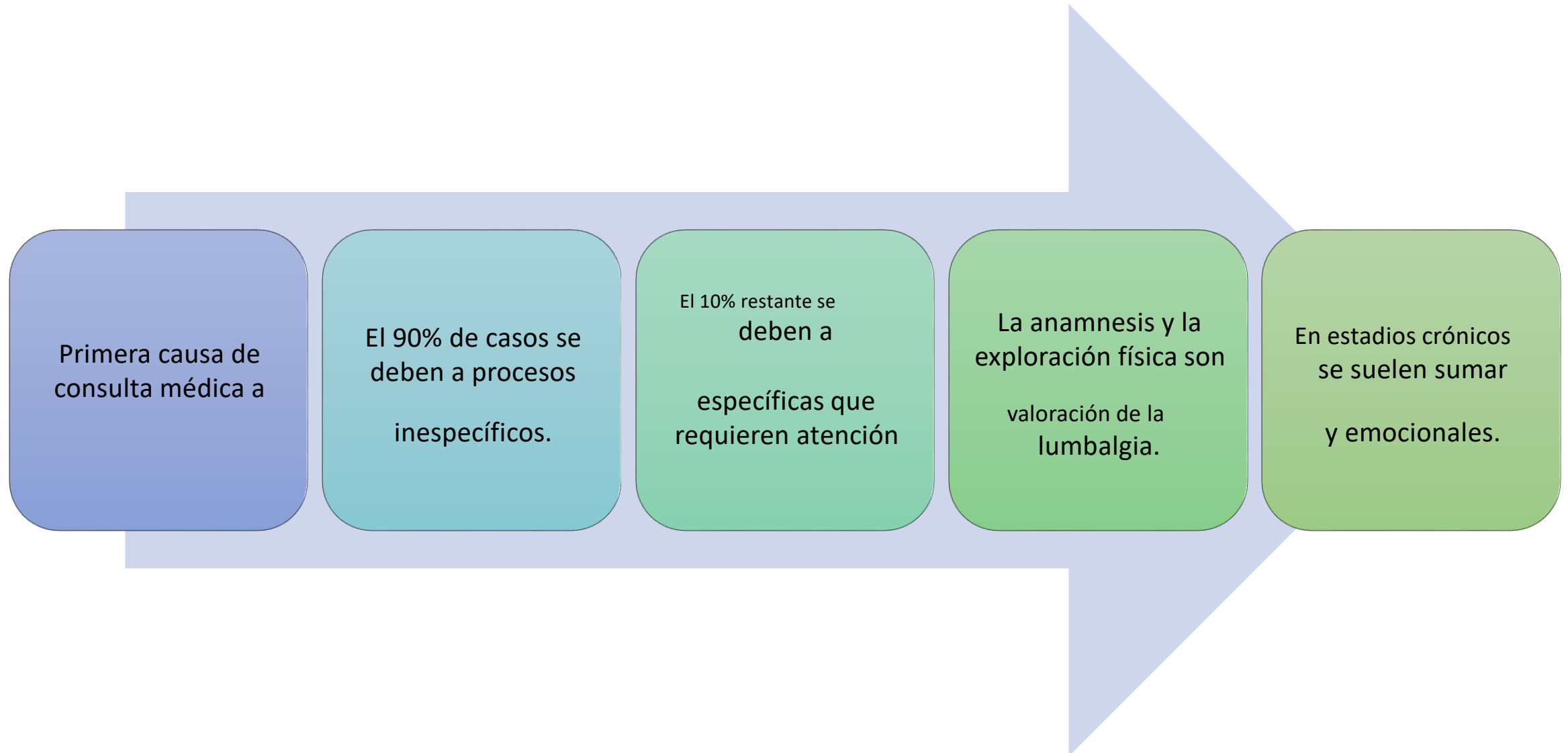


Presente.





“Dolor localizado
entre el borde inferior
y el pliegue inferior de
la zona glútea con o





Dolor

- El dolor puede tener según el tipo de lumbalgia, el tiempo de desarrollo y
- En los inespecíficos se a tejidos



Dificultad de movimiento

- Debido al dolor, la disminuida.
- En causas degenerativas, los estructuras nivel de la columna.



Cambios en el tono muscular

- Ante estímulos mecánicos el tono
- El propio dolor puede de el tono muscular.

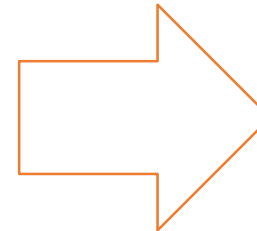


Alteración de la sensibilidad

- El dolor puede presentar irradiación hacia la zona
- Pueden sumarse a la parestesias



Presente.



**Considerar
derivación
(Banderas rojas)**

Según la irradiación

No radicular

- Origen mecánico, postural, funcional o muscular
- Asociado a la actividad física y sobreesfuerzo
- Es regional y disminuye al reposo

Radicular

- Compresión mecánica y mecanismos
- Asociado a discopatías traumáticas o degenerativas
- Lumbociática (dolor al sentarse y al acostarse)

Según el tiempo

Agudo / subagudo

- Inicio súbito
- Duración menor a 1 mes

Crónico

- Suele ser recidivante o recurrente
- Duración más de 1 mes

Según el origen

Traumático

- Adquirido por lesión
- Por movimiento brusco, accidente,

Congénito

- Problema en la formación
- Espina bífida, sacralización, etc.

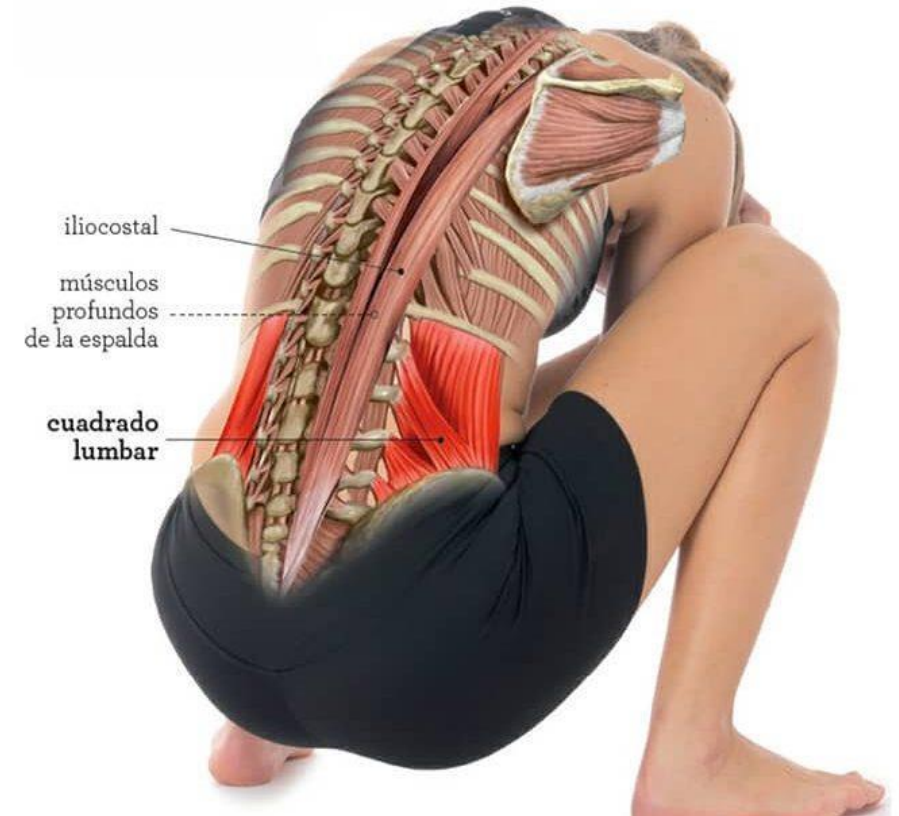
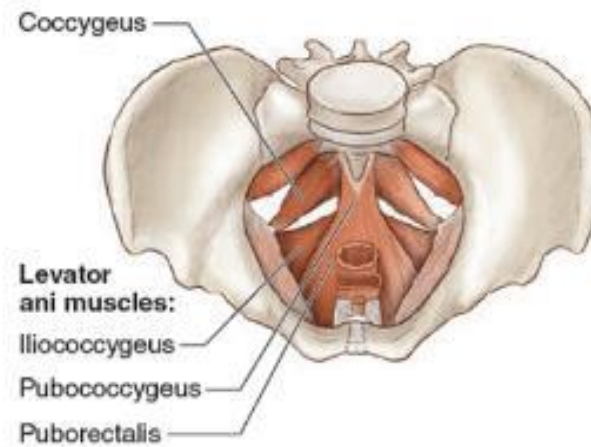
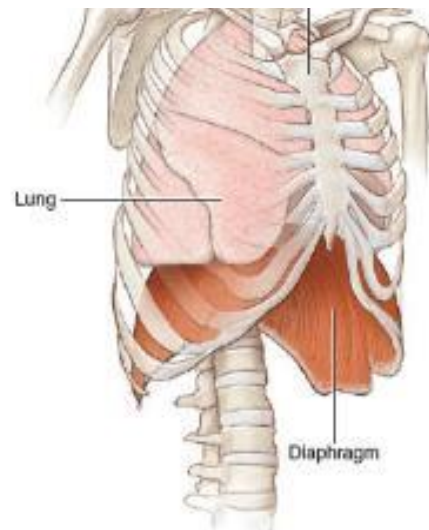
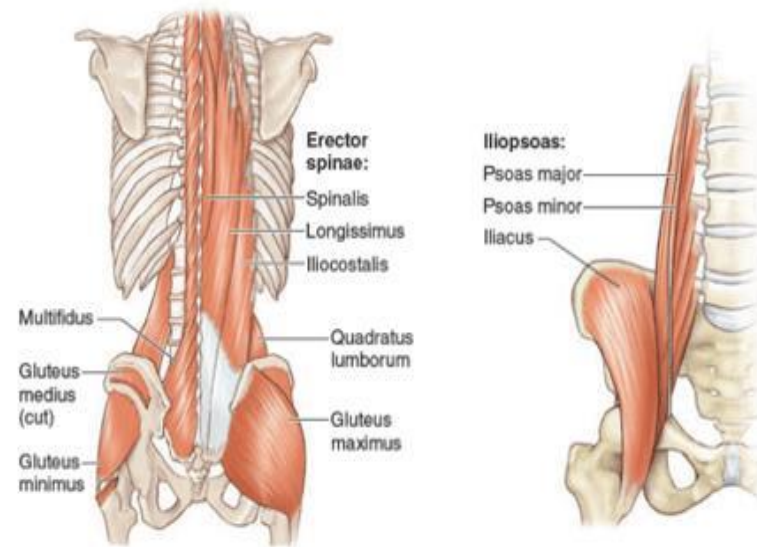
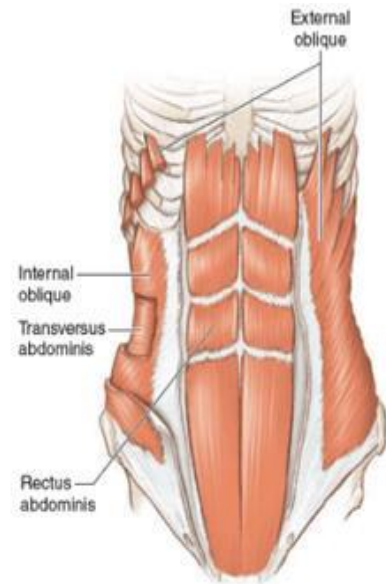
Según el dolor

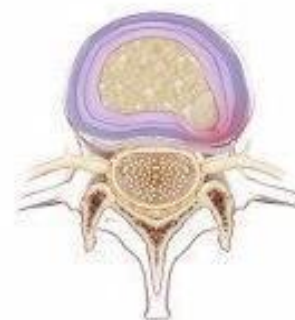
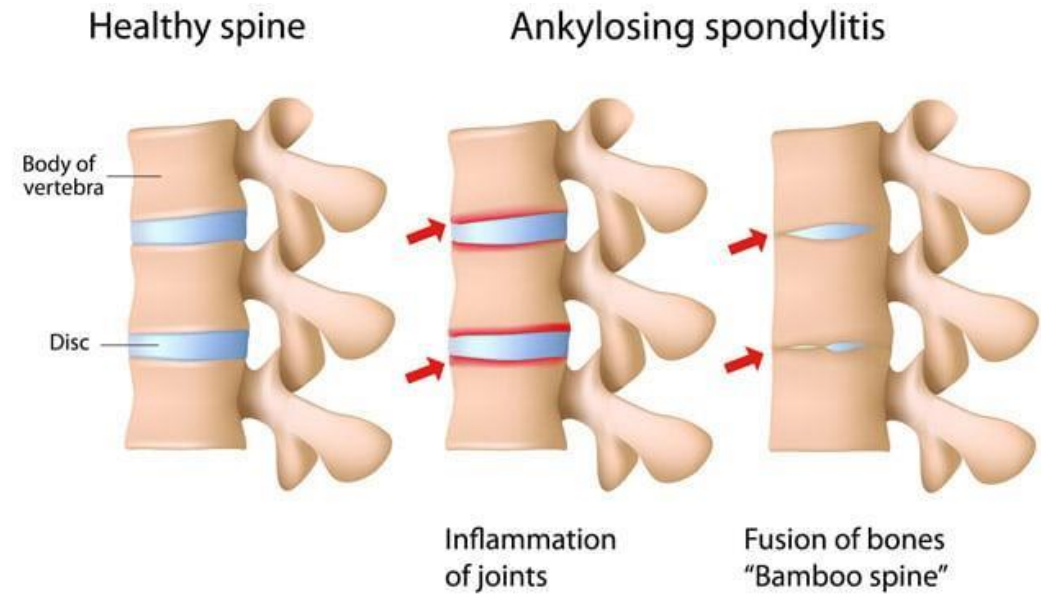
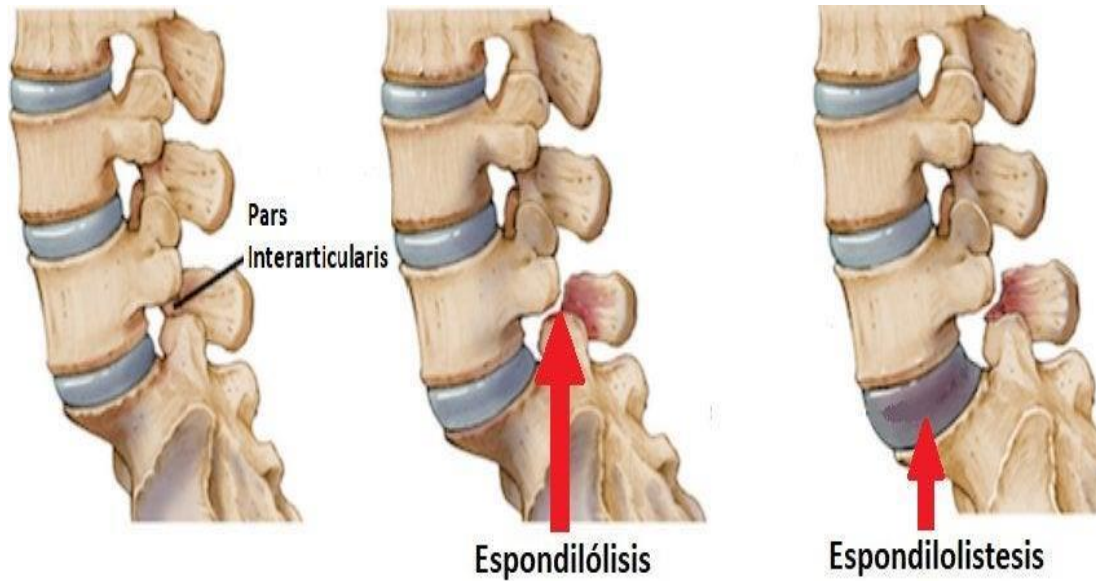
Mecánico

- La alteración no es ubicable pero se entiende que está asociado al sistema musculo esquelético
- Empeora a los movimientos y disminuye al reposo

No mecánico

- Debido a enfermedades específicas
- Suele mantenerse y requerir tratamiento





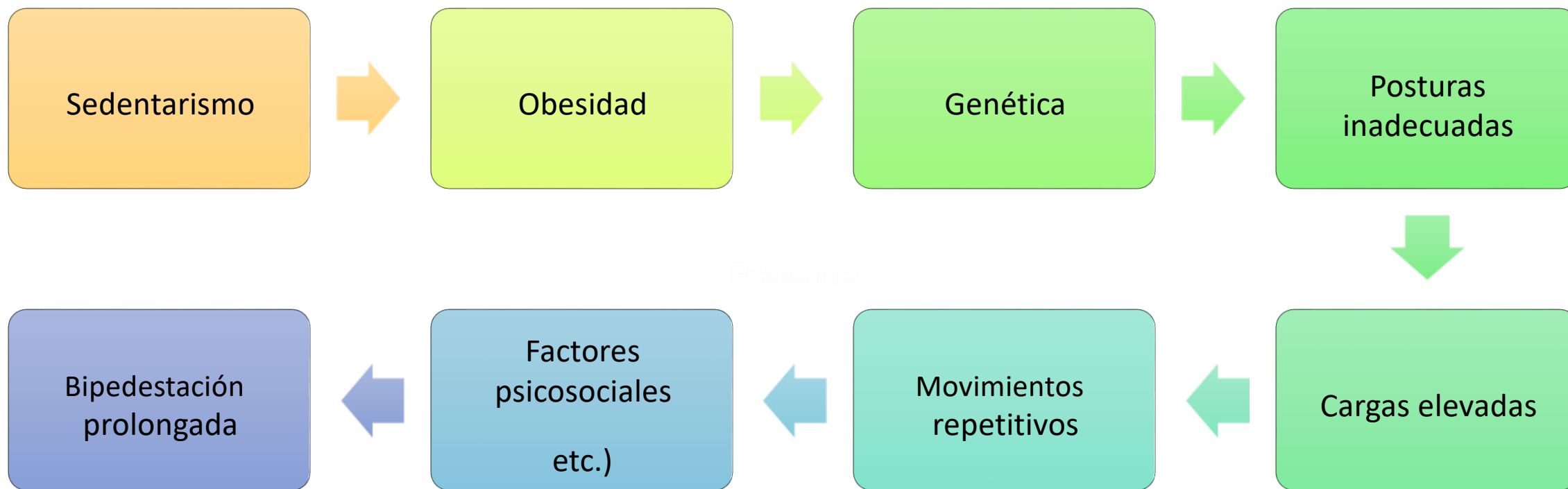
Protrusión



Extrusión



Secuestro



Evaluación médica



Imagenología (Rx, TAC, RMN).



Electromiografía de la zona y miembros inferiores.



Clínica y resultados de laboratorio.

Evaluación fisioterapéutica



Anamnesis sobre características sociodemográficas, antecedentes resultados previos.



Observación de la postura, características de la marcha y zona lumbar y pélvica.



Valoración de las características del dolor (intensidad, localización, duración, irradiación, etc).



Exploración de los rangos de movimiento (flexibilidad) y fuerza

Evaluación fisioterapéutica



Palpación de tejidos con dolor (musculatura lumbar, pélvica, abdominal y femoral) y valoración de la sensibilidad.



Empleo de pruebas clínicas específicas (Lasegue, Bragard,



Medición de la capacidad funcional, coordinación y equilibrio acorde a sus actividades diarias personales y laborales.



Valorar la presencia de factores psicosociales como el miedo al movimiento, depresión, ansiedad, estrés, entre otros.

Disminuir el dolor

Mejorar la flexibilidad de la columna lumbar y miembros inferiores

Aumentar la fuerza muscular de la columna lumbar y miembros inferiores

Mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida diaria

Educación del paciente sobre la enfermedad

Disminuir
dolor

Termoterapia
(CHC, IR)

Crioterapia

Masoterapia
relajante

Electroterapia
(TENS)

Ultrasonido
pulsátil



Mejorar la
flexibilidad de la
y miembros
inferiores

Estiramientos
osteomusculares
(cadena posterior)

Movilizaciones
articulares en
pelvis

Tracciones lumbares
con equipos o



Aumentar la
fuerza muscular

lumbar y
miembros

Ejercicios de
fortalecimiento
(extensión)



Fortalecimiento del
core stability



Ejercicios resistidos
para cuádriceps e



Mejorar la
funcionalidad
actividades de
la vida diaria

Actividades
funcionales que
axial

Considerar
movimientos y
según su ocupación

Considerar cambios en
el entorno laboral



Educación del paciente enfermedad

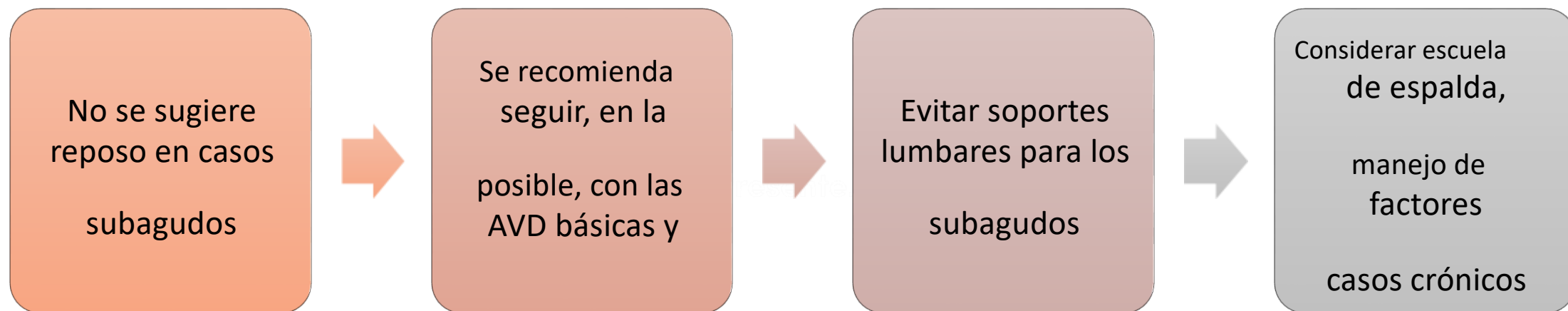
Comprensión sobre el
funcionamiento de la columna

Educación sobre estrategias
(ejercicios, higiene postural)

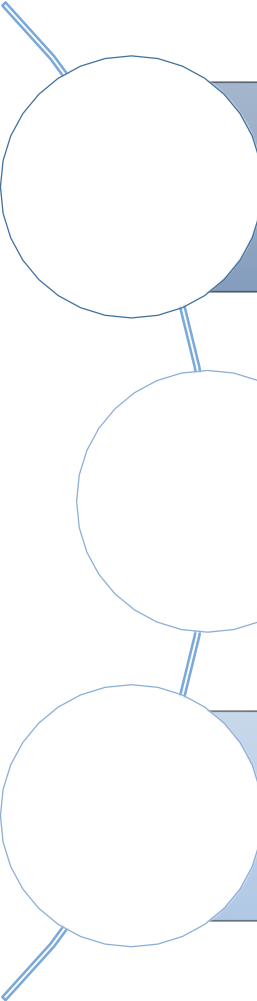
prevenir complicaciones

Reeducación postural y
ergonómica

CONSIDERACIONES







1. El dolor lumbar es un dolor localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea con o sin irradiación.

2. El dolor lumbar puede dividirse según los criterios de tiempo (agudo/crónico), origen

3. Por lo general, en un caso de dolor lumbar inespecífico la fisioterapia buscará disminuir el dolor (e inflamación si lo hubiera), incrementar la flexibilidad y fuerza muscular de la columna lumbar y miembros

- Carbayo J, Rodríguez J, Sastre J. Lumbalgia. Rev Clin Med Fam. 2012; 5(2): 140-143. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2012000200011
- Garro K. Lumbalgias. Medicina Legal de Costa Rica. 2012; 29(2): 103-109. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v29n2/art11.pdf>
- Chavarria J. Lumbalgias: causas, diagnóstico y manejo. Revista Médica de Costa Rica. 2014; 71(611): 447-454. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc143n.pdf>
- Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de lumbalgia. Lima: ESSALUD; 2016. Disponible en: https://ietsi.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/GPC-lumbalgia_version_corta-1.pdf
- Universidad de Santander. Guía de Fisioterapia para manejo y tratamiento de lumbalgia. Santander: 2008. Disponible en: https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.58.pdf

PREGUNTAS ACLARACIONES



Realizar un programa de tratamiento adecuado demostrando el uso correcto de estrategias según

María Inés tiene 35 años, actualmente es oficinista y dentro de sus hobbies se encuentra el jugar vóley, actividad que no ha vuelto a practicar desde el inicio de su dolor lumbar hacia mediados de abril de 2023. En la evaluación médica se descartó compromiso vertebral y se diagnosticó una lumbalgia mecánica. La paciente refiere un dolor EVA 7 en la zona lumbar (cuadrado lumbar) y glútea (piriforme) sobre todo al pasar de sedente a bípedo o al estar mucho tiempo parada. A la exploración se halló una flexibilidad disminuida de la cadena posterior de ambos miembros inferiores así como una poca movilidad pélvica. Además, la fuerza muscular de cuádriceps y prensa abdominal se halla en un nivel 4-. Asimismo, presenta un aminorado equilibrio estático y durante la marcha.



MUCHAS GRACIAS

Presente.